[redacted]
SALUD PÚBLICA PARA PSICÓLOGOS

EJE 01 · PSICOLOGÍA

Salud Pública

Del análisis poblacional a la acción comunitaria y la respuesta sanitaria.



01	29	7.ª
EJE OFICIAL	TEMAS DESARROLLADOS	EDICIÓN · OCT. 2026

Contenido y diseño [redacted] · [redacted] · [redacted]

[redacted] conservan sus licencias

EJE 01 · MAPA DE ESTUDIO

Tu ruta por el eje

Del análisis poblacional a la acción comunitaria y la respuesta sanitaria.

01

Fundamentos y epidemiología

Conceptos que permiten leer la situación de salud, medirla y decidir dónde intervenir.

12 TEMAS

02

Dete itorio

La salud icas y culturales que requiere

13 TEMAS

03

Promoción, bioseguridad y emergencias

Herramientas para fortalecer capacidades, proteger a equipos y organizar respuestas antes, durante y después de una emergencia.

4 TEMAS

RUTA DE USO

01 **COMPRENDE**
Relaciona ideas

02 **RECUPERA**
Explícalo sin mirar

03 **PRACTICA**
Corrige tus errores

conservan sus licencias

01

Fundamentos y epidemiología

Conceptos que permiten leer la situación de salud, medirla y decidir dónde intervenir.

EN ESTE RECORRIDO

01 **Salud Pública y Funciones iológicas e indicadores**

03 **Causalidad, riesgo y criter sición poblacional**

05 **Historia natural y niveles de as y tamizaje**

07 **Brote, epidemia, endemia, epizootia y pandemia**

08 **Vigilancia en Salud Pública**

09 **Prevención y control de infecciones**

10 **Uso racional de medicamentos**

11 **ASIS y sala situacional**

12 **Sistema Nacional de Vigilancia**

OBJETIVO DEL CAPÍTULO

Revisa la ruta, explica cada tema con tus palabras y después practica con casos.

conservan sus licencias

TEMA 01 · EJE 01

Salud Pública y Funciones Esenciales

La Salud Pública mira lo que ocurre en una población y actúa sobre las condiciones que influyen en su salud. No se ocupa únicamente de atender enfermedades: identifica necesidades, previene riesgos, promueve bienestar y organiza respuestas colectivas. Las Funciones Esenciales señalan qué capacidades necesita el sistema para evaluar, decidir, asignar recursos, asegurar el acceso y rendir cuentas.

CONCEPTOS QUE SOSTIENEN EL TEMA

Salud Pública
Disciplina y acción colectiva orientada a proteger y mejorar la salud de una población.

Población
Conjunto de personas definido por territorio, características o periodo; es la unidad principal de

Función esencial
Capacidad que el sistema de s dir cuentas.

LAS 11 FESP RENOV LO

01	Evaluar 1) monitoreo de vestigación y conocimiento · ¿ mos?
02	Formular políticas 4) políticas y legislación; 5) participación y movilización social · ¿Qué decisiones colectivas se necesitan y con quiénes?
03	Asignar recursos 6) recursos humanos; 7) medicamentos y tecnologías; 8) financiamiento · ¿Qué capacidades y recursos permitirán responder?
04	Garantizar acceso 9) servicios integrales; 10) promoción y reducción de riesgos; 11) acción sobre determinantes sociales · ¿Cómo aseguramos intervenciones efectivas, equitativas y sostenidas?

conservan sus licencias

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Unidad de análisis: población, territorio y determinantes; no solo la persona que consulta.
02	Integra promoción, prevención, vigilancia, regulación, planificación y evaluación.
03	Las FESP describen lo que el sistema debe ser capaz de hacer de manera sostenida.
04	En las FESP renovadas, la participación y movilización social incorpora comunidad organizada, sociedad civil y otros actores en la formulación y ejecución de respuestas colectivas.

CLAVE DE EXAMEN **Si el caso exige una respuesta colectiva, intersectorial o poblacional, piensa primero en Salud Pública.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

TEMA 02 · EJE 01

Mediciones epidemiológicas e indicadores

La epidemiología cuantifica frecuencia, distribución y asociación. El numerador, el denominador, la población en riesgo y el periodo determinan qué medida corresponde.

CONCEPTOS QUE SOSTIENEN EL TEMA

Numerador
Cantidad de eventos observados: por ejemplo, casos nuevos, casos existentes o defunciones.

Denominador
Población de referencia con la que se relaciona el numerador; define qué significa el indicador.

Población en riesgo
Personas que podían presenta
durante el periodo estudiado.

e cuentan los eventos. Sin tiempo y la medida queda incompleta.

QUÉ MIDE CADA IN

Incidencia	Caso riesg	ión y riesgo
Prevalencia	Caso total	
Mortalidad	Defunciones / población	Impacto poblacional
Letalidad	Defunciones por la causa / casos	Gravedad entre quienes enfermaron

conservan sus licencias

VARIANTES QUE SUELEN CONFUNDIRSE

Medida	Denominador o tiempo	Uso típico
Incidencia acumulada	Personas sanas al inicio	Riesgo de enfermar en una cohorte cerrada
Densidad de incidencia	Suma de persona-tiempo en riesgo	Población dinámica o seguimientos diferentes
Tasa de ataque	Personas expuestas durante un brote	Incidencia acumulada en exposición aguda
Ataque secundario	Contactos susceptibles de casos primarios	Propagación entre contactos cercanos
Prevalencia puntual	Población en un momento	Carga presente en una fecha
Prevalencia de periodo	Población durante un intervalo	Casos presentes en un lapso

CUATRO EJEMPLOS A MEDIDA CORRECTA

Medida	Situación		Interpretación
Incidencia acumulada	Entre 900 pers problema al ini 45 casos nuevo año.		En ese año, 5 de cada 100 personas en riesgo desarrollaron el problema.
Prevalenci a puntual	El día de la enc de 1 000 habit con el problem		En ese momento, 12 de cada 100 habitantes presentan el problema.
Mortalida d	En una población habitantes ocurre muertes por la causa durante un año.		Equivale a 80 muertes por 100 000 habitantes en ese periodo.
Letalidad	Entre 200 personas que enfermaron, 8 fallecieron por esa enfermedad.	8 / 200 = 4 %	Fallecieron 4 de cada 100 casos; expresa gravedad entre quienes enfermaron.

conservan sus licencias

Del dato al indicador

Concepto	Cómo reconocerlo	No confundir
Dato individual	Resultado de tamizaje de una persona; exige protección de identidad.	No describe por sí solo a la población.
Dato consolidado	Agrupa registros: cantidad de tamizajes positivos en un periodo y ámbito definidos.	En P40 de 2026-II, la clave oficial es D: consolidadas de salud.
Proporción de positividad	Positivos / personas tamizadas × 100, si el denominador son personas únicas comparables.	No equivale automáticamente a prevalencia poblacional ni a diagnósticos confirmados.

Fuentes de esta ampliación: [E] MINSA · Cuadernillo oficial Psicología 2026-II

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Incidencia: casos riodo.
02	Prevalencia: casos to o periodo.
03	Letalidad: muerte rmedad.
04	Mortalidad: muer
05	Razón compara c l denominador; tasa incorpora velocid

CLAVE DE EXAMEN **Casos ; gravedad entre enfermos = letalidad.**

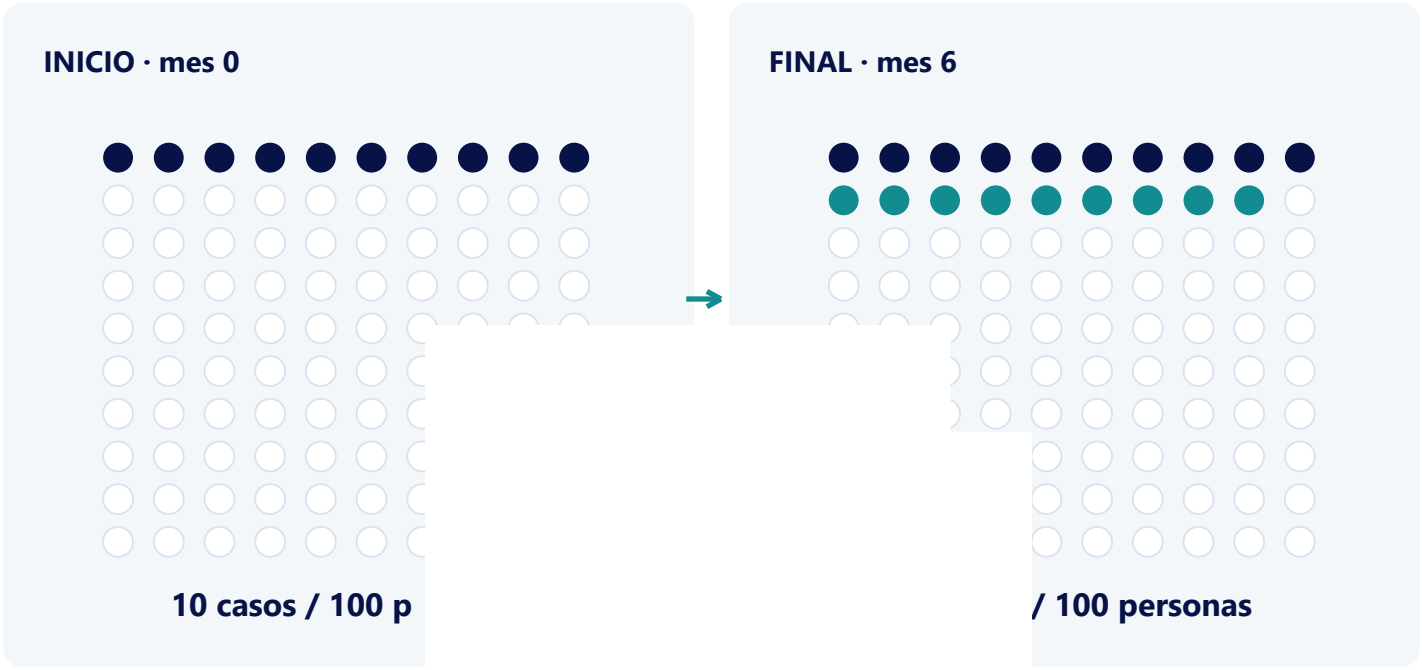
Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

Incidencia y prevalencia

Una fotografía de casos existentes y una secuencia de casos nuevos.

Población ficticia de 100 personas durante 6 meses. No hay entradas, salidas, fallecimientos ni recuperaciones; los 10 casos iniciales continúan.



● 10 casos iniciales

la condición

PREVALENCIA PUNTUAL

Inicio: **10 / 100 = 10 %**
Final: **19 / 100 = 19 %**

Cuenta todos los casos presentes en cada momento.

INCIDENCIA ACUMULADA

9 / 90 = 10 % en 6 meses

Los 90 sin la condición al inicio forman la población en riesgo.

REPASO ACTIVO

¿Por qué no dividimos los 9 casos nuevos entre 100?

Los 10 casos iniciales no pertenecen al denominador de personas inicialmente libres de la condición.

La tasa o densidad de incidencia usa persona-tiempo; es una medida diferente de la incidencia acumulada mostrada aquí.

CDC · Principles of Epidemiology, lección 3, sección 2: medidas de frecuencia. Ejemplo:

conservan sus licencias

TEMA 03 · EJE 01

Causalidad, riesgo y criterios de Hill

Una asociación puede explicarse por una relación causal, pero también por azar, sesgo o confusión. Por eso la inferencia causal combina diseño, magnitud, coherencia con otras evidencias y criterios de Hill. La temporalidad es indispensable: la exposición debe ocurrir antes del desenlace; los demás criterios aumentan o disminuyen la plausibilidad, pero no funcionan como una lista que «prueba» causalidad.

CONCEPTOS QUE SOSTIENEN EL TEMA

Asociación
Relación estadística entre una exposición y un desenlace. Puede ser causal o explicarse por otros factores.

Causa
Factor que participa en la producción del desenlace; en salud suele actuar junto con otros factores.

Confusor
Tercer factor relacionado con l
desenlace que puede crear o d
juzgar si una asociación es
no son una lista de
e.

Riesgo relativo - RR
Compara el riesgo en expuesto
expuestos. RR = 1 indica igual
sugiere riesgo y RR menor que
. Es la medida habitual en
s y aproxima al RR cuando

Riesgo atribuible - RA
Diferencia entre la incidencia de e
incidencia de no expuestos. Expresa el exceso de riesgo entre quienes estuvieron expuestos.

lacional - RAP
a de toda la población y la
incidencia de no expuestos. Estima el impacto potencial a nivel poblacional.

conservan sus licencias

LOS 9 CRITERIOS DE HILL, EN LENGUAJE SENCILLO

Fuerza
La asociación observada tiene una magnitud importante.

Consistencia
Distintos estudios encuentran resultados parecidos.

Especificidad
Una exposición se vincula especialmente con un efecto.

Gradiente biológico
Al aumentar la exposición, aumenta o cambia el efecto.

EL PUNTO QUE
NO PUEDE FALTAR

TEMPORALIDAD

La exposición ocurre
antes del desenlace

Plausibilidad
Existe una explicación biológica o científica posible.

Coherencia
La relación no contradice la historia natural ni otra evidencia sólida.

Experimento
Modificar la exposición modifica el desenlac

ogía
idas conocidas apoyan la

conservan sus licencias

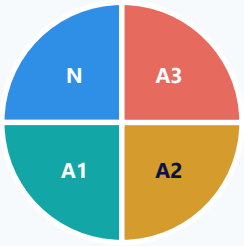
LECTURA Y PRECISIONES DEL ESQUEMA

Criterio	Qué significa	Cómo reconocerlo
Temporalidad	La exposición ocurrió antes que el desenlace.	Es el único criterio indispensable.
Fuerza	La asociación observada tiene una magnitud importante.	Un RR u OR más alejado de 1 sugiere mayor fuerza.
Consistencia	Distintos estudios encuentran resultados parecidos.	Se repite en poblaciones, lugares o métodos diferentes.
Especificidad	Una exposición se vincula especialmente con un efecto.	Ayuda, pero no siempre existe en causas multifactoriales.
Gradiente biológico	Al aumentar la exposición, aumenta o cambia el efecto.	También se llama relación dosis-respuesta.
Plausibilidad	Existe una explicación biológica o científica posible.	Es compatible con el conocimiento disponible.
Coherencia	La na	os encajan entre sí.
Experimento	M de	e al retirar o controlar la
Analogía	Re ap	produce un efecto

CÓMO SE COMPLET

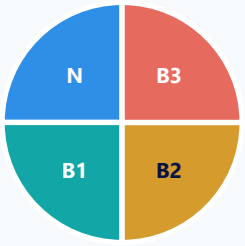
Dos mecanismos diferentes pueden pr

CAUSA SUFICIENTE A



PASTEL COMPLETO → DESENLACE

CAUSA SUFICIENTE B



PASTEL COMPLETO → DESENLACE

N = CAUSA NECESARIA

Está en todos los mecanismos; cada A o B es una causa componente. Si falta una pieza, ese mecanismo no se completa.

conservan sus licencias

LECTURA Y PRECISIONES DEL ESQUEMA

Mecanismo	Componentes	Lectura
Causa suficiente A	N + A1 + A2 + A3	Al completarse todas las piezas, ocurre el desenlace por este mecanismo.
Causa suficiente B	N + B1 + B2 + B3	Otro conjunto de componentes puede conducir al mismo desenlace.
Causa necesaria N	Aparece en A y B	Está presente en todos los mecanismos suficientes del ejemplo.

UN EJEMPLO BREVE PARA RECONOCER CADA CRITERIO DE HILL

Criterio	Ejemplo ilustrativo	Qué debes interpretar
Temporalidad	El consumo de tabaco comenzó antes de que apareciera el cáncer de	La exposición precede al desenlace; sin esta secuencia no puede sostenerse causalidad.
Fuerza	Q pr pu no	a de asociación muy alejada del uerza, aunque no elimina
Consistencia	Es pa un	oduce bajo circunstancias
Especificidad	La de marc	vamente específica apoya puede faltar en daños
Gradiente biológico	A mayor número de paquetes-año de tabaco, mayor riesgo de cáncer de pulmón.	El efecto cambia con la dosis o intensidad de la exposición.
Plausibilidad	Los carcinógenos del humo pueden dañar el ADN de las células respiratorias.	Existe un mecanismo compatible con el conocimiento científico disponible.
Coherencia	La epidemiología, la anatomía patológica y la historia natural apuntan en la misma dirección.	La explicación encaja con otras evidencias sólidas y no las contradice.
Experimento	Tras dejar de fumar, el riesgo disminuye progresivamente con el tiempo.	Modificar o retirar la exposición modifica el desenlace esperado.
Analogía	Otros carcinógenos inhalados producen lesiones respiratorias comparables.	Una relación causal semejante conocida hace más verosímil la hipótesis.

conservan sus licencias

MODELOS DE CAUSALIDAD Y PIEZAS DE ROTHMAN: DEL CONCEPTO AL EJEMPLO

Concepto	Definición sencilla	Ejemplo didáctico	Pista para reconocerlo
Modelo unicausal	Una causa específica se plantea como explicación directa de un efecto específico.	Modelo clásico: virus de la rabia → rabia; ayuda a identificar el agente, aunque el desenlace real también depende del huésped.	Es útil en algunos daños infecciosos o tóxicos; resulta limitado para problemas crónicos y multifactoriales.
Modelo multicausal	Varios factores interactúan de manera probabilística para producir el daño.	Depresión: vulnerabilidad previa, violencia, aislamiento, pérdida laboral y escaso apoyo pueden combinarse de formas distintas.	Integra persona, agente o exposición, ambiente y condiciones sociales; ningún factor aislado explica todos los casos.
Causa suficiente	Conjunto completo de causas componentes que, al reunirse, produce el desenlac	Un mecanismo de cáncer pulmonar puede completarse con tabaco, susceptibilidad genética, edad y otra	Es el pastel causal completo; pueden existir varios pasteles diferentes para un mismo daño.
Causa componente	Cada factor una causa s pero que n necesariam el daño por		Es una porción del pastel; prevenir una causa componente puede impedir los mecanismos que la contienen.
Causa necesaria	Factor que presente en causas sufic desenlace.		Sin ella el daño no ocurre; necesaria no significa suficiente.

Tríada epidemiológica

Tríada epidemiológica: agente, huésped y ambiente interactúan en la producción de enfermedad. El agente puede ser biológico, químico o físico; en factores químicos o nutricionales, tanto el exceso como la carencia relativa pueden causar daño, como la falta de un nutriente esencial; el huésped aporta susceptibilidad y respuesta; el ambiente facilita o limita la exposición. Identificar un agente no elimina la contribución de las otras dos dimensiones.

Fuentes: [R066] CDC. Principles of Epidemiology in Public Health Practice, 3rd edition · [R067] OPS. Glosario sobre brotes y epidemias: un recurso para periodistas y comunicadores

conservan sus licencias

ANCLAS PARA RECORDAR

01	La temporalidad es indispensable: la exposición debe preceder al desenlace.
02	Riesgo relativo compara incidencias; odds ratio compara odds y es frecuente en casos y controles.
03	Riesgo atribuible estima el exceso de riesgo entre las personas expuestas que puede relacionarse con la exposición.
04	Riesgo atribuible poblacional estima cuánto disminuiría el riesgo de toda la población si se eliminara la exposición, bajo un supuesto causal.
05	Factor de riesgo aumenta probabilidad; factor protector la reduce.
06	Confusión distorsiona la asociación; interacción modifica el efecto según un tercer factor.

CLAVE DE EXAMEN **Entr es condición necesaria.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicol

conservan sus licencias

RR, OR y riesgo atribuible: un mismo caso, preguntas distintas

Antes de calcular, distingue frecuencia, comparación relativa y diferencia absoluta. Todos los números de esta página son didácticos.

Seguimiento de un año	Enferman	No enferman	Total
Expuestos	20	80	100
No expuestos	10	90	100

Incidencia acumulada en expuestos: 20/100 = 20 %. En no expuestos: 10/100 = 10 %. Las personas estaban libres del desenlace al inicio y el seguimiento se considera completo.

Medida	Cálculo	Qué responde
RR	0,	bservado es el doble.
OR	(2	veces las de no expuestos.
Diferencia de riesgos	0,	les por cada 100 expuestos.
Fracción atribuible en expuestos	(2	ible bajo supuestos causales.

LA PISTA DECISIVA

10 puntos porcentuales es una escribe el cambio de 10 %
a 20 %. No son magnitudes inter

Si la mitad de la población está expuesta, el riesgo poblacional es 15 %. El riesgo atribuible poblacional sería 15 % − 10 % = 5 puntos porcentuales. Interpretarlo como evitable exige causalidad y que la eliminación de la exposición sea una intervención pertinente; una asociación sola no lo garantiza.

Fuentes: [N05], [N07].

conservan sus licencias

Sesgo, confusión y modificación de efecto

Una asociación estadística puede ser válida como cálculo y, aun así, interpretarse mal.

Concepto	Cómo aparece	Qué hacer
Azar	Variación del muestreo; estimación imprecisa.	Describir incertidumbre con un intervalo y revisar tamaño muestral.
Sesgo de selección	La entrada o permanencia en el estudio distorsiona la comparación.	Definir población de origen y revisar selección y pérdidas.
Sesgo de información	Exposición o desenlace se miden de forma incorrecta o diferente entre grupos.	Estandarizar medición y revisar errores diferenciales.
Confusión	Un factor previo, relacionado con exposición y desenlace, distorsiona su asociación; no es un paso intermedio causal.	Prevenir mediante diseño o controlar mediante estratificación o ajuste.
Modificación de efecto	La ma defini	escribir los efectos por grupo; no atarla automáticamente como error.

CASO APLICADO

Un estudio relaciona turnos no
no es consecuencia del turno,
social, puede existir modificaci

evia se asocia con ambos y
cambia según apoyo

Aumentar la muestra puede red
variables disponibles tampoco e
distorsionar el efecto que se desea

ico. Ajustar por todas las
bles inapropiadas puede

Fuentes: [N05], [N06].

conservan sus licencias

TEMA 04 · EJE 01

Demografía y transición poblacional

La demografía estudia tamaño, estructura y dinámica de la población. Natalidad, mortalidad, fecundidad, migración, esperanza de vida y dependencia orientan servicios y políticas.

INDICADORES DE ESTRUCTURA Y DINÁMICA POBLACIONAL

Natalidad	Nacidos vivos / población x 1 000	Frecuencia de nacimientos en la población
Mortalidad	Defunciones / población x 1 000	Frecuencia de muertes en la población
Fecundidad general	Naci a 49	tiva en edad fértil
Dependencia	(0 a 64 añ	potencial sobre la
Crecimiento natural	Naci	l sin considerar

conservan sus licencias

LECTURA RÁPIDA DE PIRÁMIDES POBLACIONALES

EXPANSIVA



Base ancha: alta natalidad y población joven.

ESTACIONARIA



Anchura estable: natalidad y mortalidad más equilibradas.

REGRESIVA



LEE DE ABAJO HACIA ARRIBA

Base = edades jóvenes · cima = edades mayores · esquemas didácticos, sin porcentajes reales.

LECTURA Y PRECISIONES DEL ESQUEMA

Forma	Aspecto	Interpretación
Expansiva o progresiva	Base ancha y cima estrecha	Alta natalidad y población predominantemente joven
Estacionaria	Anchura relativamente uniforme	Natalidad y mortalidad más equilibradas
Regresiva	Base estrecha y mayor peso en edades medias/altas	Baja natalidad y envejecimiento
Desequilibrada	Entrantes, salientes o asimetrías marcadas	Migración, guerra u otro evento altera la estructura

conservan sus licencias

ANCLAS PARA RECORDAR

01	La pirámide expansiva sugiere población joven; la regresiva, envejecimiento.
02	La transición demográfica combina caída de mortalidad y posterior caída de fecundidad.
03	La transición epidemiológica desplaza el peso hacia enfermedades crónicas, sin eliminar infecciones.

CLAVE DE EXAMEN **El envejecimiento poblacional modifica demanda, dependencia y continuidad del cuidado.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

TEMA 05 · EJE 01

Historia natural y niveles de prevención

La historia natural recorre periodo prepatogénico, patogénico subclínico y clínico. Cada nivel preventivo se reconoce por el momento y la intención.

Prevención primordial e infección subclínica

Prevención primordial: evita que aparezcan condiciones y patrones que generan factores de riesgo. Prevención primaria: reduce la aparición de enfermedad mediante promoción y protección específica; ambas pueden compartir acciones, pero su objetivo conceptual difiere. Fase subclínica: el proceso patológico ya comenzó, aunque aún no haya manifestaciones clínicas. La mera exposición sin síntomas no demuestra infección ni permite asignar automáticamente esta fase; una gestante expuesta a rubéola requiere evaluación oportuna.

Fuentes: [R077] OMS/EMRO. Noncommun gion · [R066] CDC. Principles of Epidemiology in Public Health Practice, 3rd edition · [R07 acunas

UBICA EL MOMENT

01	Antes del daño Primaria · Evitar
02	Fase subclínica Secundaria · Det
03	Daño establecido Terciaria · Reducir
04	Riesgo de sobreuso Cuaternaria · Evitar daño innecesario · No indicar pruebas sin beneficio

conservan sus licencias

ANCLAS PARA RECORDAR

01
Primaria: promoción y protección específica antes del daño.

02
Secundaria: tamizaje, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno.

03
Terciaria: limitar daño, rehabilitar y reducir secuelas.

04
Cuaternaria: evitar intervenciones innecesarias y daño por sobreuso.

CLAVE DE EXAMEN **Vacunar es prevención primaria; tamizar es secundaria; rehabilitar es terciaria.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

TEMA 06 · EJE 01

Pruebas diagnósticas y tamizaje

El rendimiento se interpreta comparando la prueba con un patrón de referencia. Sensibilidad y especificidad son propiedades de la prueba; valores predictivos cambian con la prevalencia.

CONCEPTOS QUE SOSTIENEN EL TEMA

VP · verdadero positivo
La prueba es positiva y la condición realmente está presente.

VN · verdadero negativo
La prueba es negativa y la condición realmente está ausente.

FP · falso positivo
La prueba es positiva, pero la c

FN · falso negativo
a, pero la condición sí está

Patrón de referencia
Método aceptado para determ
no tiene la condición; permite

personas aparentemente
necesita una evaluación

QUÉ SIGNIFICA CAD

Medida	Definición sencil		Lectura
Sensibilidad	Entre quienes sí ti condición, ¿cuántos salen positivos?		Alta: deja pocos falsos negativos.
Especificidad	Entre quienes no tienen la condición, ¿cuántos salen negativos?	VN / (VN + FP)	Alta: deja pocos falsos positivos.
VPP	Si la prueba salió positiva, ¿qué probabilidad hay de que la condición esté presente?	VP / (VP + FP)	Suele aumentar cuando la prevalencia aumenta.
VPN	Si la prueba salió negativa, ¿qué probabilidad hay de que la condición esté ausente?	VN / (VN + FN)	Suele aumentar cuando la prevalencia disminuye.

conservan sus licencias

EJEMPLO RESUELTO: DE LA TABLA 2 × 2 A LAS CUATRO MEDIDAS

Dato o medida	Numerador y denominador	Resultado	Lectura sencilla
Datos de 100 personas	40 tienen la condición: 36 VP y 4 FN. De 60 sin la condición: 48 VN y 12 FP.	VP 36 · FN 4 · VN 48 · FP 12	Primero ubica la realidad y luego el resultado de la prueba.
Sensibilidad	VP / (VP + FN) = 36 / 40	90 %	Detectó a 90 de cada 100 personas que sí tenían la condición.
Especificidad	VN / (VN + FP) = 48 / 60	80 %	Clasificó como negativas a 80 de cada 100 personas sin la condición.
VPP	VP / (VP + FP) = 36 / 48	75 %	Entre los resultados positivos, 75 de cada 100 correspondieron a personas con la condición.
VPN	VN / (VN + FN) = 48 / 52	92,3 %	Entre los resultados negativos, aproximadamente 92 de cada 100 espondieron a personas sin la dición.
No memorices sin contexto	En esta mu es 40 / 100		la misma prueba, los valores pueden cambiar en otra

ANCLAS PARA REC

01	Sensibilidad = ver bilidad reduce falsos negativos.
02	Especificidad = verd icidad reduce falsos positivos.
03	VPP: probabilidad de enfermedad con prueba positiva. VPN: probabilidad de no enfermedad con prueba negativa.
04	Tamizaje se aplica a población aparentemente sana y requiere confirmación diagnóstica.

CLAVE DE EXAMEN **Prueba sensible negativa ayuda a descartar; prueba específica positiva ayuda a confirmar.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

Sensibilidad y especificidad

La pregunta determina qué grupo va en el denominador.

Ejemplo ficticio: 100 personas evaluadas con una prueba y un patrón de referencia. La condición está presente en 40 y ausente en 60.

PRUEBA	CONDICIÓN PRESENTE	CONDICIÓN AUSENTE	TOTAL
POSITIVA	**32** Verdaderos positivos · VP	**12** Falsos positivos · FP	**44**
NEGATIVA	Fa	**8** · VN	**56**
TOTAL			**100**

Sensibilidad

Entre quienes tienen la condición.

32 / (32 + 8) = 80 %

.

80 %

VPP · valor predictivo positivo

Entre los resultados positivos.

32 / (32 + 12) = 72,7 %

VPN · valor predictivo negativo

Entre los resultados negativos.

48 / (48 + 8) = 85,7 %

REPASO ACTIVO

“Tiene la condición: ¿qué probabilidad hay de que la prueba salga positiva?”

Sensibilidad. Si la pregunta parte de un resultado positivo, corresponde al VPP.

CDC · Screening for HIV, apéndice, p. 12. Fórmulas de rendimiento diagnóstico. Ejemplo numérico:

conservan sus licencias

Una prueba positiva no tiene siempre el mismo significado

La prevalencia previa cambia cuánto informa un resultado. Ejemplo ficticio: sensibilidad y especificidad de 90 % en dos poblaciones.

En 1 000 personas	Prevalencia 1 %	Prevalencia 50 %
Con la condición	10	500
Verdaderos positivos / falsos negativos	9 / 1	450 / 50
Falsos positivos / verdaderos negativos	99 / 891	50 / 450
VPP	9/(9+99) = 8,3 %	450/(450+50) = 90 %

En la población de baja prevalen e se examinan 990 personas sin la condición. No significa que la pr ejemplo: cambió la composición de la población.

NO CONVIERTAS UNA REGLA DE M

Una prueba sensible negativa u interpretación depende de la probabilidad previa, el p basta por sí sola.

En la práctica, sensibilidad y esp pacientes y la forma de verificar el diagnóstico. Un tamiz uivale a diagnóstico confirmado ni su proporción eq

APLICACIÓN EN PSICOLOGÍA

Si se tamiza depresión en una campaña, registra personas únicas, versión, punto de corte y población. La entrevista y la ruta diagnóstica deben estar previstas antes de ofrecer el tamizaje.

Fuentes: [N05], [N10].

conservan sus licencias

TEMA 07 · EJE 01

Brote, epidemia, endemia, epizootia y pandemia

> Los términos describen el comportamiento observado frente a lo esperado en tiempo, lugar y población.

R0 y Rt

R0 es el número medio de infecciones secundarias que produciría un caso en una población completamente susceptible, sin intervenciones. Rt describe la reproducción efectiva en un momento concreto, considerando susceptibilidad y medidas de control. Rt mayor que 1 favorece expansión; igual a 1, transmisión estable en promedio; menor que 1, descenso. Observar un brote no permite calcular por sí solo R0 ni confundirlo con Rt.

Fuentes: [R068] Guzzetta y colaboradores. issibility, Italy

LA DIFERENCIA EST IÓN

Término	Cri	
Brote	A	stablecimiento
Epidemia	M	o definidos
Endemia	Pr	sostenido
Epizootia	Aum animales	e riesgo zoonótico
Pandemia	Epidemia de amplia extensión internacional	Múltiples países o continentes

conservan sus licencias

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Brote: aumento localizado o agrupación de casos vinculados.
02	Epidemia: casos por encima de lo esperado en una población y periodo.
03	Endemia: presencia habitual o esperada de un evento en un área.
04	Pandemia: epidemia extendida a múltiples países o continentes.
05	Epizootia afecta animales y puede tener relevancia zoonótica.

CLAVE DE EXAMEN **La palabra decisiva suele ser «por encima de lo esperado», no un número absoluto.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

Investigar un brote: describir para decidir

Las tareas se superponen y pueden repetirse. Las medidas de control pertinentes no deben esperar a que termine toda la investigación.

Tarea	Producto útil
Verificar la señal y el diagnóstico	¿El aumento supera lo esperado? ¿Hay cambios de registro o pruebas?
Definir caso	Criterios de persona, lugar, tiempo y clínica; laboratorio cuando corresponda al evento.
Buscar y ordenar casos	Listado nominal protegido, fechas de inicio, exposiciones y desenlaces.
Describir	Curva por inicio de síntomas, distribución territorial y grupos afectados.
Formular y contrastar hipótesis	Exposiciones plausibles; estudio analítico si es necesario y viable.
Controlar, comunicar y evaluar	idades, vigilancia y retroalimentación.

UNA CURVA NO IDENTIFICA POR S

Un pico puede sugerir exposic a. El patrón también depende de incubación, búsqu , laboratorio y territorio.

La fecha de notificación puede e síntomas describe mejor la secuencia de enfermedad. No in tiva de caso facilita comparar registros y puede refinarse dura

Fuentes: [N05], [N06].

conservan sus licencias

TEMA 08 · EJE 01

Vigilancia en Salud Pública

La vigilancia sirve para convertir datos en una respuesta sanitaria oportuna. En la modalidad pasiva, los servicios notifican los casos que encuentran durante la atención. En la activa, el equipo sale a buscarlos. La vigilancia centinela observa tendencias con un protocolo común en unidades seleccionadas. Pasiva y activa indican cómo se captan los casos; centinela indica dónde se los observa. Las categorías sospechoso, probable, confirmado y descartado dependen de la definición de cada evento.

CONCEPTOS QUE SOSTIENEN EL TEMA

Vigilancia pasiva
Los casos se reconocen durant
el personal los notifica; el siste
de manera sistemática.

Vigilancia activa
le busca casos de forma deliberada
registros, laboratorios, visitas a
comunitaria.

Vigilancia centinela
Una red limitada de unidades s
datos estandarizados y detalla
tendencias o características de

tifica a quien cumple
ser notificado o
del evento.

Caso probable
Caso sospechoso con evidenci
el evento, todavía sin cumplir n
confirmatorio final.

confirmatorio establecido
puede variar entre
ógico o criterio clínico

EL CICLO DE VIGILANCIA TERMINA EN ACCIÓN

01	Recolectar y notificar · Datos oportunos y comparables
02	Analizar e interpretar · Señales, tendencias y grupos de riesgo
03	Difundir y retroalimentar · Información útil para quienes deciden
04	Intervenir y evaluar · Respuesta sanitaria y aprendizaje

conservan sus licencias

PASIVA, ACTIVA Y CENTINELA: CÓMO SE OBTIENE LA INFORMACIÓN

Estrategia	Cómo funciona	Ventaja principal	Límite y ejemplo
Pasiva	El personal reconoce el caso durante la atención habitual y lo notifica por los canales regulares.	Amplia cobertura con menor uso adicional de recursos.	Puede haber subregistro o demora. Ejemplo: casos captados en consulta y reportados por el establecimiento.
Activa	Epidemiología busca intencionalmente casos en historias clínicas, laboratorios, servicios o comunidad.	Mayor sensibilidad y oportunidad en situaciones prioritarias.	Requiere más tiempo y personal. Ejemplo: búsqueda diaria durante un brote o en UPSS seleccionadas.
Centinela	Unidades seleccionadas aplican definiciones, procedimientos y registros estandarizados observar un ev	Datos detallados y de buena calidad para vigilar tendencias y características.	No cuenta necesariamente todos los casos. Ejemplo: vigilancia de problemas de salud mental en establecimientos centinela.

conservan sus licencias

DE SOSPECHOSO A CONFIRMADO: LA DEFINICIÓN DEL EVENTO MANDA

Clasificación	Significado general	Para qué sirve	Precisión indispensable
Caso sospechoso	Cumple criterios clínicos y/o epidemiológicos iniciales compatibles con el evento.	Activa notificación, investigación, toma de muestra o medidas inmediatas cuando corresponda.	No equivale a diagnóstico definitivo.
Caso probable	El sospechoso reúne evidencia adicional, como nexo epidemiológico, imagen compatible o prueba de apoyo no definitiva.	Aumenta la certeza operacional y orienta el seguimiento o la respuesta.	La evidencia exigida cambia según la enfermedad o evento.
Caso confirmado	Cumple el criterio confirmatorio admitido por la d eve	Permite la clasificación final y consolida el análisis	Puede ser por laboratorio, nexo epidemiológico o criterio clínico si la norma específica lo autoriza.
Caso descartado	Tra crit con otr		Un resultado negativo aislado no siempre descarta: depende del evento, muestra y momento.

Dengue: reconocimi

Dengue probable: fiebre de hasta vios a una zona con transmisión o presencia de Aedes, y al menos dos manifestaciones compatibles, como cefalea, dolor retroocular, mialgias, artralgias, náuseas/vómitos o exantema. En niños, la definición admite fiebre sin foco aparente de hasta siete días con el mismo antecedente epidemiológico. Signos de alarma, como dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes o sangrado de mucosas, requieren evaluación urgente. Dengue grave implica choque o dificultad respiratoria por extravasación de plasma, hemorragia grave o compromiso grave de órganos. La disminución de la fiebre no garantiza recuperación; confirmar y clasificar según evaluación y norma.

Fuentes: [R072] MINSA. Atención integral de pacientes con dengue en el Perú · [R073] MINSA. Vigilancia epidemiológica y diagnóstico de laboratorio de dengue, chikungunya, zika, Oropouche, Mayaro y otras arbovirosis

conservan sus licencias

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Vigilancia pasiva: el servicio detecta casos durante la atención habitual y los notifica por la red establecida; cubre ampliamente con menor costo, pero puede tener subregistro o demora.
02	Vigilancia activa: el equipo de epidemiología busca deliberadamente casos mediante revisión de historias, laboratorios, visitas a servicios o búsqueda comunitaria; mejora oportunidad y sensibilidad, pero demanda más recursos.
03	Vigilancia centinela: establecimientos o poblaciones seleccionadas aplican un protocolo común y producen información detallada sobre tendencias o características; no pretende contar necesariamente todos los casos del territorio.
04	Sospechoso, probable y confirmado son clasificaciones operacionales. Los criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio exactos dependen de la definición oficial vigente para cada evento.
05	La oportunidad, s aceptabilidad evalúan el sistema.
06	Notificación inme rano para investigar y responder sin esp cta un evento notificable lo com epidemiológica del establecimiento o ón por la red establecida. Para firmación de laboratorio ni una reunión de la atención.
07	Registrar y comu torias, laboratorios o territorio para enco
08	En vigilancia de sarampión/rubéola, fiebre y erupción maculopapular generalizada activan sospecha, notificación e investigación. La NTS 247 (2026) incluye también a quien el personal asistencial sospecha que tiene sarampión o rubéola. La confirmación sigue los criterios específicos: clínicos, epidemiológicos y laboratoriales conjuntamente, aislamiento viral o nexo documentado con otro caso confirmado, según la directiva de vigilancia. La mera exposición no confirma infección. «Probable» no es una etapa obligatoria para todos los eventos.

CLAVE DE EXAMEN **Pasiva y activa explican cómo se buscan los casos; centinela señala dónde y con qué red seleccionada se observa. La definición específica del evento siempre prevalece.**

Fuente: CDC Perú: Vigilancia epidemiológica y páginas oficiales de vigilancia por evento. Las definiciones exactas de caso se consultan en la norma vigente del daño correspondiente.

Fuentes: [R069] MINSA. Notificación de enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiológica · [R070] CDC Perú. Vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunas · [R071] MINSA. Prevención, diagnóstico y manejo del sarampión en el Perú

conservan sus licencias

TEMA 09 · EJE 01

Prevención y control de infecciones

Las precauciones estándar se aplican a toda persona atendida. Las adicionales dependen de la vía de transmisión.

PRECAUCIONES SEGÚN VÍA DE TRANSMISIÓN

Tipo	Medida destacada	Idea clave
Estándar	Higiene de manos y EPP según riesgo	Se aplica a toda persona
Contacto	Guantes, bata y ambiente/equipo seguro	Evitar transmisión por superficies o contacto
Gotas	M	espiratorias de corto alcance
Aerosoles	Re	manecen suspendidas

ANCLAS PARA REC

01	Higiene de mano éptica, después del riesgo de contact ués de tocar su entorno. Los guantes no la arlos cuando corresponda a est vista; cambiarlos entre pacientes y tareas c
02	Equipo de protección personal conforme al riesgo de exposición.
03	Manejo seguro de punzocortantes, ropa, residuos, equipos y ambiente.
04	Precauciones por contacto, gotas o aerosoles se añaden cuando corresponda. Influenza estacional: aplicar precauciones estándar y por gotas, con mascarilla médica en la atención indicada. Para procedimientos que generan aerosoles, usar respirador N95 o equivalente con ajuste adecuado, además de protección ocular, bata y guantes. El EPP depende de la actividad y del riesgo; no toda entrevista exige automáticamente el mismo conjunto de barreras.
05	La vigilancia de IAAS permite medir la frecuencia basal, detectar incrementos o conglomerados, investigar y evaluar las medidas de control.

CLAVE DE EXAMEN **Las precauciones estándar no dependen del diagnóstico conocido.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

Fuentes: [R060] OMS. Cinco momentos para la higiene de manos · [R061] OMS. Preguntas frecuentes, Día Mundial de la Higiene de Manos 2025 · [R062] CDC. Infection Prevention and Control Strategies for Seasonal Influenza in Healthcare Settings

conservan sus licencias

TEMA 10 · EJE 01

Uso racional de medicamentos

> Implica que la persona reciba el medicamento apropiado, en dosis y duración adecuadas, al menor costo posible para ella y la comunidad.

ESENCIALES Y USO RESPONSABLE

Un medicamento esencial responde a necesidades prioritarias de salud. Su selección considera relevancia sanitaria, eficacia, seguridad y costos comparados; debe estar disponible en cantidad suficiente, forma farmacéutica apropiada, calidad garantizada y condiciones asequibles. Esencial expresa prioridad sanitaria; no depende de que el producto use marca o denominación genérica. En Perú, la selección se concreta en el PNUME y sus listas complementarias vigentes.

El uso innecesario o inadecuado de antimicrobianos favorece la selección y propagación de microorganismos resistentes y desarrollan resistencia son los microorganismos, no la perso guir la evaluación profesional.

Fuentes: [R050] OMS, Essential medicines ión 05/07/2023), PNUME · [R052] OMS, ficha Resistencia a los antimicrobian

QUIÉN HACE QUÉ

• DIGEMID: autoridad naciona s y productos sanitarios; ejerce regulación, autorización

• CENARES: gestiona el abaste l sistema público, incluida su adquisición y distribución s

• DIGESA: ámbito de salud ambi

Identifica la función central del caso. La autoridad que regula y vigila medicamentos no debe confundirse con el órgano que organiza su abastecimiento. Una pregunta que mezcla ambas funciones necesita esa precisión.

Fuentes: [R053] DIGEMID, información institucional vigente al corte; ROF MINSA DS008-2017-SA y modificatorias · [R054] CENARES, información institucional oficial, consulta 19/10/2026 UTC · [R055] DIGESA, información institucional oficial, consulta 19/10/2026 UTC

conservan sus licencias

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Prescripción basada en necesidad, evidencia, seguridad y contraindicaciones.
02	Evitar automedicación, polifarmacia injustificada y antimicrobianos sin indicación.
03	Farmacovigilancia detecta, evalúa y previene reacciones adversas.
04	En psicología, reconocer riesgos, adherencia y necesidad de derivación sin invadir competencias médicas.

CLAVE DE EXAMEN **Uso racional combina indicación correcta, dosis correcta, tiempo correcto y seguimiento.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

TEMA 11 · EJE 01

ASIS y sala situacional

El Análisis de Situación de Salud reúne datos epidemiológicos, sociales y ambientales junto con la mirada de la comunidad. Así permite precisar qué problemas existen, a quiénes afectan y por qué. Con esa base se priorizan necesidades y se planifican acciones. La sala situacional mantiene información actualizada para seguir cambios, alertas, brechas y avances.

CONCEPTOS QUE SOSTIENEN EL TEMA

ASIS
Proceso que describe y explica problemas, determinantes, brechas y recursos de una población para priorizar.

Sala situacional
Espacio y proceso de análisis continuo que organiza información actualizada para tomar decisiones.

Priorización
Elección ordenada de problem y valoración social.

Actores de la sala si

La sala situacional sirve al equi rritorio: autoridades locales, sectores y representantes com ión según su función; su uso no se restringe a epidemi oteger la confidencialidad y traducir el análisis en acuerdos

Fuentes: [R074] MINSA. Metodología para el a

RUTA PRÁCTICA DEL ASIS

01	Caracterizar Territorio, población, recursos y determinantes · Perfil territorial
02	Medir Daños, brechas y tendencias · Problemas identificados
03	Priorizar Magnitud, gravedad, vulnerabilidad y factibilidad · Agenda sanitaria
04	Actuar Objetivos, responsables e indicadores · Plan y seguimiento

conservan sus licencias

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Caracterizar territorio y población; describir daños y determinantes; identificar brechas.
02	Priorizar con magnitud, trascendencia, vulnerabilidad, factibilidad y percepción social.
03	Triangular información cuantitativa, cualitativa y participación comunitaria.
04	El producto debe orientar un plan, no ser solo un informe descriptivo.

CLAVE DE EXAMEN **ASIS analiza y prioriza; la sala situacional actualiza y acompaña la decisión.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

TEMA 12 · EJE 01

Sistema Nacional de Vigilancia

Articula establecimientos, redes, direcciones regionales y nivel nacional para detectar eventos, notificar, investigar y responder.

ANCLAS PARA RECORDAR

01	La definición de caso estandariza quién se registra.
02	El flujo respeta canales y plazos, pero una urgencia activa respuesta inmediata.
03	La investigación epidemiológica verifica diagnóstico, busca contactos y controla el foco.

CLAVE DE EXAMEN **Noti** **ad funcional, no una tarea** **opci**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicol

conservan sus licencias

Leer un mapa epidemiológico: el ejemplo de John Snow

El mapa de 1854 relaciona muertes por cólera con calles y bombas de agua. Es una fuente histórica para aprender a formular hipótesis.



Mapa de muertes por cólera y bombas de

John Snow · Public domain. Sin recorte; escala prop

Fuente

Casos y territorio

Observa la concentración de marcas y su cercanía a una fuente de agua. El dibujo ayudó a orientar una hipótesis sobre transmisión y una intervención; no contiene, por sí solo, todos los datos necesarios para probar causalidad.

QUÉ OBSERVAR

arcas ubican muertes y su entración cerca de las fuentes de . La distribución orienta hipótesis; información adicional para

PREGUNTAS PARA LEER LA IMAGEN

¿Qué representa cada marca? ¿Cuál es la población expuesta? ¿Falta un denominador? ¿Dónde viven quienes no enfermaron? Un mapa de conteos puede reflejar tanto riesgo como mayor concentración de habitantes.

Fuentes: [N05].

conservan sus licencias

02

Determinantes, comunidad y territorio

La salud se produce en condiciones sociales, ambientales, económicas y culturales que requieren trabajo con la comunidad.

EN ESTE RECORRIDO

13 Determinantes sociales d bientales

15 Participación comunitaria ha familiar

17 Intervenciones comunitar rial

19 Plan local de salud

20 Información sanitaria y TIC

21 Alimentación, nutrición e inocuidad

22 Residuos sólidos en servicios de salud

23 Salud ocupacional y riesgos psicosociales

24 Modelo comunitario de salud mental

25 Barreras de acceso

OBJETIVO DEL CAPÍTULO

Revisa la ruta, explica cada tema con tus palabras y después practica con casos.

conservan sus licencias

TEMA 13 · EJE 01

Determinantes sociales de la salud

Son las condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, junto con la distribución de poder, dinero y recursos.

DE LA ESTRUCTURA A LA EXPERIENCIA COTIDIANA

01

DETERMINANTES ESTRUCTURALES

Contexto político, económico y social, y posición socioeconómica vinculada con educación, ocupación, ingresos, clase social, género y etnia. · Configuran la distribución de poder y recursos.

02

DETERM

Condiciones
es, conductuales y biológicos. ·
Producen ex

03

SI

Per
roducir inequidades.

LECTURA Y PRECISIO

Nivel	Incluye	Cómo influye
Determinantes estructurales	Contexto político, económico y social, y posición socioeconómica vinculada con educación, ocupación, ingresos, clase social, género y etnia.	Configuran la distribución de poder y recursos.
Determinantes intermedios	Condiciones materiales de vivienda y trabajo, factores psicosociales, conductuales y biológicos.	Producen exposiciones concretas.
Sistema de salud	Pertenece a los determinantes intermedios.	Puede reducir o reproducir inequidades.

conservan sus licencias

Determinantes estructurales e intermedios

La educación influye en conocimientos, oportunidades laborales, ingresos y capacidad de utilizar recursos para la salud.

Fuentes: [R087] OMS. A conceptual framework for action on the social determinants of health

ANCLAS PARA RECORDAR

01
Estructurales: contexto político y posición socioeconómica, incluidos educación, ocupación e ingresos, género y etnia.

02
Intermedios: condiciones de vivienda y trabajo, factores psicosociales, conductuales y biológicos, y sistema de salud.

03
Inequidad es una diferencia injusta, evitable y sistemática.

CLAVE DE EXAMEN **Equi cesidades diferentes.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicol

Fuentes: [R087] OMS. A conceptual frame

conservan sus licencias

TEMA 14 · EJE 01

Determinantes ambientales

Agua, aire, clima, vivienda, saneamiento, ruido, vectores y exposición a contaminantes influyen en salud física y mental.

Exposición, agente y riesgo

Concepto	Cómo reconocerlo	No confundir
Xenobiótico	Sustancia química ajena al organismo: por ejemplo, un fármaco o un contaminante.	No significa necesariamente tóxico; el daño depende también de dosis, vía y duración.
Exposición	Contacto por inhalación, ingestión o po	La presencia de un agente en el ambiente no por sí sola enfermedad.
Riesgo ambiental	Va vu la	ífica no identifica por sí te.

Fuentes de esta ampliación: [X] IUPAC · Xe

Clave oficial observ

Concepto	Có	
Examen histórico	Psico clave epidemiológica.	r sugería una secuencia ir a otra alternativa.
Lectura clínica	La clave del cuadernillo no sustituye la evaluación de seguridad ni el protocolo para exposición a mercurio.	No convertir la alternativa marcada en una regla universal que retrase proteger a las personas.
Regla para estudiar	Conservar la clave oficial cuando se revisa ese examen; diferenciarla del manejo técnico de una exposición real.	No cambiar silenciosamente una clave histórica para hacerla coincidir con una explicación.

Fuentes de esta ampliación: [E] MINSA · Cuadernillo oficial Psicología 2026-II

conservan sus licencias

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Identificar fuente, vía de exposición, población vulnerable y efecto.
02	El cambio climático modifica riesgos por calor, desastres, vectores y seguridad alimentaria.
03	La respuesta combina vigilancia sanitaria y epidemiológica, regulación, comunicación y acción intersectorial.
04	La respuesta a mercurio exige seguridad, evaluación de la exposición y activación de la ruta sanitaria y epidemiológica; revisar por separado la clave oficial de P87 de 2026-II.
05	En enfermedades metaxénicas, eliminar criaderos y controlar recipientes con agua actúa sobre la fuente del vector; la fumigación no reemplaza esas medidas domiciliarias y comunitarias. El dengue se transmite principalmente por la picadura de hembras infectadas de Aedes aegypti. Su actividad es diurna, con mayor intensidad al amanecer y al final de la tarde; puede picar en otros momentos del día. Eliminar criaderos, tapar y limpiar recipientes y evitar picaduras complementa las acciones comunitarias de control.

CLAVE DE EXAMEN **Ant** **pertenece solo al** **esta**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicol

Fuentes: [R088] OMS Europa. Public health

conservan sus licencias

TEMA 15 · EJE 01

Participación comunitaria

> Es la intervención activa de la población en diagnóstico, priorización, planificación, ejecución y evaluación de acciones de salud.

Participación situada en el territorio

Para organizar la participación, delimitar el territorio y reconocer actores, familias y organizaciones; habilitar espacios donde puedan deliberar y decidir; y acordar acciones, responsables y seguimiento. Articular estos elementos favorece continuidad y pertinencia. La sola asistencia a reuniones o la existencia de un comité no garantizan participación efectiva ni el éxito de una intervención.

Fuentes: [R074] MINSA. Metodología para el análisis de situación de salud local · [R078] OMS. Primary health care

ANCLAS PARA REC

01	Informar no equiv idad de decisión.
02	Mapeo de actore onflictos.
03	La sostenibilidad ceso.

CLAVE DE EXAMEN **La c idado colectivo.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología

conservan sus licencias

TEMA 16 · EJE 01

Sectorización y ficha familiar

La sectorización organiza el territorio y asigna población para conocer riesgos, familias y recursos. La ficha familiar registra composición, condiciones y necesidades.

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Permite seguimiento nominal y priorización de familias vulnerables.
02	Integra visita domiciliaria, mapa del sector y actualización periódica.
03	La carpeta familiar reúne y ordena los formatos e información de la familia; la ficha familiar es uno de sus registros centrales y no debe confundirse con toda la carpeta.
04	La información d acción sanitaria.

CLAVE DE EXAMEN **Sect o solo dividir un mapa.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicol

conservan sus licencias

TEMA 17 · EJE 01

Intervenciones comunitarias

Parten de un problema priorizado, objetivos medibles, población definida, estrategia pertinente e indicadores de proceso y resultado.

DISEÑO DE UNA INTERVENCIÓN COMUNITARIA

01	Diagnóstico participativo · ¿Qué problema reconoce el territorio?
02	Objetivo y población · ¿Qué cambio, en quiénes y cuándo?
03	Estrategia pertin
04	Indicadores y ev

ANCLAS PARA REC

01
Diagnóstico participativo ant sos → actividades → actividades.

03
Adaptar lenguaje, canal y horario al territorio.

04
Evaluar cobertura, calidad, cambio logrado y sostenibilidad.

CLAVE DE EXAMEN **Una actividad aislada no es una intervención si no responde a objetivo, población e indicador.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

TEMA 18 · EJE 01

Trabajo intersectorial

Problemas complejos requieren coordinar salud con educación, municipalidad, protección, justicia, trabajo y organizaciones sociales.

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Definir problema común, roles, responsables, plazos y mecanismos de seguimiento.
02	La coordinación puede ser multisectorial; la intersectorialidad busca acción integrada.
03	Evitar derivaciones sin cierre ni retroalimentación.

CLAVE DE EXAMEN **Inte** **com** **mpartida con objetivos**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicol

conservan sus licencias

TEMA 19 · EJE 01

Plan local de salud

Traduce prioridades territoriales en objetivos, actividades, responsables, recursos, cronograma e indicadores.

DEL PROBLEMA AL INDICADOR

01	Problema Qué ocurre, a quiénes, dónde y con qué magnitud · Formular una solución como problema
02	Objetivo Qué cambio medible se espera · Usar verbos vagos
03	Actividad Qué se hará par tado
04	Indicador Cómo se medirá

Responsabilidad y p

Concepto	Có	
Autoridad local de salud	Elabo sanitarias y sobre determinantes, recursos y participación de actores.	nción exclusivamente al promotor o coordinador de una estrategia.
Actores territoriales	Servicios de salud, gobierno local y organizaciones participan según sus competencias.	Participación compartida no elimina la responsabilidad de conducción sanitaria.

Fuentes de esta ampliación: [L] MINSA · Plan estratégico multisectorial al 2030 · [E] MINSA · Cuadernillo oficial Psicología 2026-II

conservan sus licencias

ANCLAS PARA RECORDAR

01
Problema bien formulado: población, magnitud, lugar y efecto.

02
Objetivo específico debe ser medible y temporal.

03
Indicador incluye fórmula, fuente, frecuencia y meta.

04
Monitoreo revisa ejecución; evaluación valora resultados.

CLAVE DE EXAMEN **Cada actividad necesita responsable, plazo, recurso e indicador.**

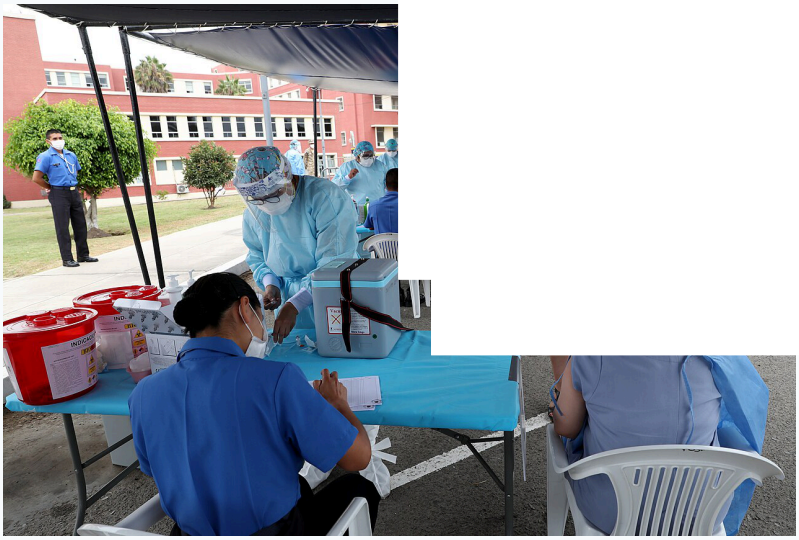
Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

Del diagnóstico comunitario a un indicador interpretable

Una actividad realizada es un producto; no demuestra por sí sola un cambio en salud. Ejemplo ficticio de continuidad después de un tamizaje.

Nivel	Ejemplo	Qué permite afirmar
Recurso	Horas del equipo y ambiente privado.	Capacidad disponible.
Actividad	Contactar a las personas que requieren evaluación.	Acción ejecutada.
Producto	80 contactos efectivos de 100 intentados.	Alcance operativo del contacto.
Resultado de acceso	60 personas completan evaluación entre 100 derivadas.	60 % de continuidad en el plazo definido.
Resultado en salud	Cam perti	lución; atribuirla al programa exige un eño adecuado.



Jornada de vacunación en el Centro Médico de la Marina de Guerra del Perú (2021).

Galería de fotografías del Ministerio de Defensa · CC BY 2.0. Sin recorte; escala proporcional.

Fuente

DO

12 charlas, pero no se
o ni cambio. El dato
ducción de actividades; no
cluir que disminuyó
n la comunidad.

icador

Ficha mínima: nombre, propósito, fórmula, unidad, población, periodo, fuente, frecuencia de medición, responsable, línea de base, meta y limitaciones. Mantener denominadores comparables y evitar duplicar personas.

La comunidad participa en elegir problemas y valorar resultados. Revisar a quiénes no llegó la intervención: una cobertura promedio puede ocultar barreras por lengua, discapacidad, distancia o recursos.

Fuentes: [N18].

conservan sus licencias

TEMA 20 · EJE 01

Información sanitaria y TIC

Los sistemas de información convierten registros en evidencia para atención y gestión. Incluyen HIS, historia clínica, receta electrónica, aseguramiento y plataformas de interoperabilidad.

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Calidad del dato: completo, consistente, oportuno y válido.
02	Registrar lo realizado con trazabilidad y confidencialidad.
03	Un indicador de tamizajes positivos usa como numerador los resultados positivos y como denominador el t y periodo definidos.
04	Interoperabilidad .
05	La tecnología apo onsabilidad profesional.

CLAVE DE EXAMEN **Dat**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicol

conservan sus licencias

TEMA 21 · EJE 01

Alimentación, nutrición e inocuidad

Hay seguridad alimentaria cuando los alimentos están disponibles, son accesibles, pueden utilizarse adecuadamente y esa situación se mantiene en el tiempo. La inocuidad busca evitar daños por contaminantes biológicos, químicos o físicos.

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Malnutrición incluye desnutrición, deficiencias, sobrepeso y obesidad.
02	Promoción alimentaria considera cultura, economía y ciclo de vida.
03	Vigilancia nutricional identifica riesgos y orienta acciones.

CLAVE DE EXAMEN **Seg … ocuidad es ausencia de peli…**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicol…

conservan sus licencias

TEMA 22 · EJE 01

Residuos sólidos en servicios de salud

La gestión segura empieza al separar los residuos donde se generan y continúa con su acondicionamiento, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final. La NTS N.° 144-MINSA/2018/DIGESA define las clases y señala qué bolsa o recipiente corresponde.

COLORES Y RECIPIENTES PARA SEGREGAR SIN CONFUNDIRSE

Clase	Color o recipiente	Ejemplos	Cuidado principal
Biocontaminado	ROJO · bolsa	Gasas con sangre, cultivos y material contaminado	Cerrar al llegar a 3/4; no compactar
Especial	AMA	Químicos, fármacos peligrosos y	Manejar según su riesgo específico
Común	NEGR	l sin	No mezclar con residuos peligrosos
Punzocortante	RÍGID		No reencapuchar; cierre hermético

ANCLAS PARA REC

01	Bolsa roja: residu uidos, cultivos o residuos de atenció
02	Bolsa amarilla: residuos especiales, como productos químicos o farmacéuticos peligrosos y otros residuos con riesgo especial.
03	Bolsa negra: residuos comunes que no estuvieron en contacto con agentes contaminantes ni presentan peligrosidad.
04	Punzocortantes: recipiente rígido, impermeable, resistente a perforaciones, rotulado y con símbolo de bioseguridad; no se reencapuchan.
05	Las bolsas y recipientes se retiran al alcanzar las tres cuartas partes de su capacidad; no deben compactarse con las manos.

CLAVE DE EXAMEN **Memoria rápida: rojo = biocontaminado; amarillo = especial; negro = común; punzocortante = recipiente rígido.**

Fuente: NTS N.° 144-MINSA/2018/DIGESA, aprobada por RM N.° 1295-2018-MINSA y modificada por RM N.° 250-2022-MINSA y RM N.° 901-2024-MINSA.

conservan sus licencias

TEMA 23 · EJE 01

Salud ocupacional y riesgos psicosociales

Protege bienestar físico, mental y social en el trabajo mediante identificación, evaluación y control de riesgos.

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Riesgos psicosociales: alta demanda, bajo control, violencia, jornadas, conflicto de rol y escaso apoyo.
02	Priorizar controles en la fuente y organización antes que solo estrategias individuales.
03	Vigilar accidentes, enfermedades ocupacionales y desgaste profesional.

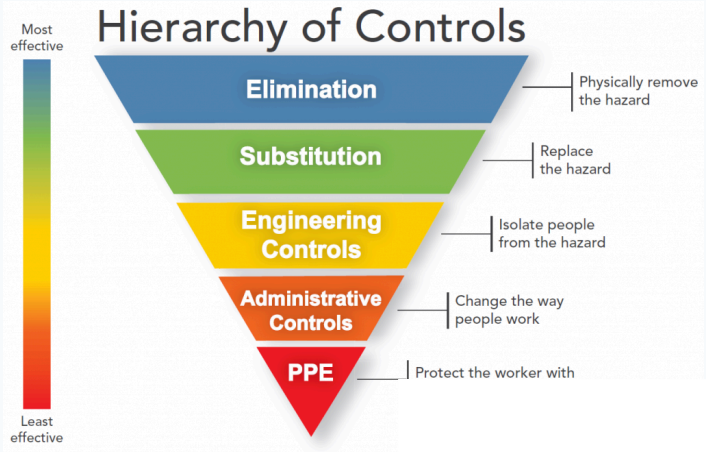
CLAVE DE EXAMEN **El b … ndo autocuidado; también se inte…**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicol…

conservan sus licencias

Controlar el riesgo laboral: actuar sobre la fuente

La jerarquía de controles ayuda a ordenar medidas. No toda medida es viable en todo escenario; se combinan según la evaluación del riesgo.



NIOSH · Public domain. Sin recorte; escala prop

Fuente

Orden de la figura	Lectura en español
Elimination / Substitution	Eliminar el peligro o reemplazarlo por una alternativa menos peligrosa, cuando sea factible.
Engineering controls	Aislar a las personas del peligro mediante el diseño del ambiente o equipos.
	Cambiar organización, flujos, procedimientos y capacitación.
	quipo de protección personal decuado, con entrenamiento y juste cuando corresponda.

RIESGO PSICOSOCIAL

Ante sobrecarga crónica, revis distribución de tareas, horario Enseñar relajación puede ayud sustituye corregir condiciones dañinas.

Fuentes: [N09].

conservan sus licencias

TEMA 24 · EJE 01

Modelo comunitario de salud mental

En el modelo comunitario, la atención ocurre lo más cerca posible de la vida cotidiana de la persona, con énfasis en derechos y recuperación. El primer nivel, los Centros de Salud Mental Comunitaria, los hospitales y los hogares protegidos trabajan con la familia y la comunidad. El objetivo es reducir síntomas y, al mismo tiempo, recuperar autonomía, vínculos, funcionamiento e inclusión con la alternativa efectiva menos restrictiva.

El CSMC también fortalece la red

Además de atender a personas, el Centro de Salud Mental Comunitaria brinda asistencia técnica, supervisión y capacitación a los equipos del primer nivel para mejorar intervenciones clínicas, psicosociales y de gestión. La derivación no elimina la responsabilidad de coordinación y seguimiento entre servicios.

Fuentes: [R017] MINSA. NTS 138-MINSA/2

Red de apoyo: reco

La red reúne apoyos cercanos, ofrece atención especializada frente a violenci y protección; DEMUNA y UPE intervienen en protección promueven derechos e inclusión de personas con disc lejidad hospitalaria.

Fuentes: [R018] MIMP. Lineamientos de co R019] Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, publicada 24-1

Orfandad: cuidado y

Ante niñas o niños que pierden a do, necesidades básicas y seguridad. Articular familia extensa y comunidad, servicios de salud mental y apoyos del INABIF según elegibilidad. Comunicar riesgo de desprotección a DEMUNA acreditada y presunta desprotección a UPE, conforme a la ruta territorial. La orfandad no determina automáticamente acogimiento residencial; las medidas requieren evaluación competente e interés superior del niño.

Fuentes: [R018] MIMP. Lineamientos de coordinación CEM-UPE-DEMUNA. RM 237-2024-MIMP, 13-07-2024 · [R020] INABIF. Asistencia económica para casos de orfandad, información oficial actualizada en 2026; Ley 31405

conservan sus licencias

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Atención cercana al entorno y con mínima restricción necesaria.
02	Trabajo interdisciplinario, plan individualizado y continuidad del cuidado.
03	Rehabilitación psicosocial e inclusión comunitaria.
04	Hospitalización cuando corresponda, evitando institucionalización prolongada.

CLAVE DE EXAMEN **El eje es recuperación e inclusión en comunidad, no aislamiento como respuesta principal.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

TEMA 25 · EJE 01

Barreras de acceso

El acceso puede limitarse por distancia, costo, idioma, horarios, estigma, discapacidad, falta de información o trato inadecuado.

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Disponibilidad: servicio existe; accesibilidad: puede alcanzarse; aceptabilidad: es pertinente; calidad: resuelve con seguridad.
02	La navegación del usuario ayuda a completar rutas y referencias.
03	Medir abandono y oportunidad permite identificar barreras ocultas. Aseguramiento universal en salud n disponga de seguro que permita acceder a s modificatorias. Cobertura universal: acceso ltades financieras. APS: enfoque de toda l orial y participación. Atención integral: go del curso de vida. Tener seguro no

CLAVE DE EXAMEN **Ofre**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicol

Fuentes: [R084] Congreso de la República. Ley e la República. Incorporación al SIS de peruanos residentes en el exterior · [R086] O S. Primary health care

conservan sus licencias

03

Promoción, bioseguridad y emergencias

Herramientas para fortalecer capacidades, proteger a equipos y organizar respuestas antes, durante y después de una emergencia.

EN ESTE RECORRIDO

26 **Promoción de la salud**

28 **Bioseguridad**

ación y comunicación

astres

OBJETIVO DEL CAPÍTULO

Revisa la ruta, explica cada tema con tus palabras y después practica con casos.

conservan sus licencias

TEMA 26 · EJE 01

Promoción de la salud

La promoción de la salud ayuda a que personas y comunidades tengan mayor control sobre su salud. Actúa mediante políticas saludables, entornos favorables, participación comunitaria, habilidades personales y servicios orientados a prevenir.

CINCO CAMPOS DE ACCIÓN DE PROMOCIÓN

Campo	Qué transforma	Ejemplo
Políticas saludables	Normas y decisiones públicas	Entornos libres de humo
Entornos favorables	Condiciones físicas y sociales	Escuela segura
Acción comunitaria	Pa	al activo
Habilidades personales	Ca	para la salud
Reorientar servicios	Or co	al

Ejes, escenarios y en

En el modelo de abordaje MIN ión y nutrición; higiene y ambiente; actividad física; salu alud mental, buen trato y cultura de paz; y seguridad vial y ción. Los escenarios son espacios como vivienda, escuela, equidad de género e interculturalidad son enfoques transversales. Estas categorías no sustituyen los cinco campos de acción de Ottawa.

Fuentes: [R083] MINSA. Modelo de abordaje de promoción de la salud en el Perú

ANCLAS PARA RECORDAR

01	No se reduce a charlas; también transforma condiciones y políticas.
02	Empoderamiento fortalece capacidad de decidir y actuar.
03	Advocacy coloca un tema en agenda; alianzas amplían capacidad de respuesta.

CLAVE DE EXAMEN **Si cambia condiciones y capacidades, es promoción; si evita un daño específico, puede ser prevención.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

TEMA 27 · EJE 01

Información, educación y comunicación

La IEC planifica mensajes y experiencias educativas según audiencia, objetivo y contexto; la comunicación de riesgo añade transparencia e incertidumbre.

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Segmentar audiencia y definir conducta o comprensión esperada.
02	Usar lenguaje claro, canal pertinente, vocería confiable y retroalimentación.
03	Pretestear materiales y evaluar alcance, comprensión y cambio.
04	Combatir rumore .

CLAVE DE EXAMEN **Más com rtinencia,**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicol

conservan sus licencias

TEMA 28 · EJE 01

Bioseguridad

Conjunto de medidas para reducir riesgos biológicos, químicos, físicos y ergonómicos en la atención.

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Evaluar riesgo antes del procedimiento y seleccionar barreras adecuadas.
02	Higiene de manos, limpieza, desinfección, esterilización y manejo de exposición.
03	La exposición ocupacional incluye pinchazos o cortes y salpicaduras de sangre o fluidos potencialmente infecciosos en mucosas o piel lesionada. Lavar la piel con agua y jabón e irrigar mucosas c evaluación inmediata del riesgo y de la pro sitivos seguros y protección de manos, ojos y car

CLAVE DE EXAMEN **La b o reemplaza prácticas seg**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicol

Fuentes: [R063] CDC/NIOSH. Bloodborne I ally Infectious Exposures and Illnesses

conservan sus licencias

TEMA 29 · EJE 01

Emergencias y desastres

La gestión del riesgo comprende estimación, prevención, reducción, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción.

COMPRENDE EL RIESGO ANTES DE INTERVENIR

Peligro	Evento con potencial de daño	Sismo, inundación o brote
Exposición	Personas y bienes en el área	Población ubicada en zona vulnerable
Vulnerabilidad	Susceptibilidad y menor capa	Vivienda precaria o aislamiento
Riesgo	Inter expo	urre el evento

Origen de los peligr

Por su origen, distinguir peligr es, de los inducidos por acción humana, como derram La actividad humana también puede agravar impact n ambiental u ocupación insegura del territorio. Peligro en de exposición y vulnerabilidad.

Fuentes: [R092] CENEPRED. Manual para la ev ión · [R093] CENEPRED. Manual para la elaboración de riesgos inducidos por la acción humana

conservan sus licencias

ANCLAS PARA RECORDAR

01
Peligro es la amenaza; vulnerabilidad es susceptibilidad; riesgo combina ambos con exposición.

02
Preparación incluye planes, brigadas, simulacros, suministros y comunicación.

03
Primeros auxilios psicológicos: observar, escuchar, conectar; no forzar relato ni psicoterapia inmediata.

04
El triage prioriza necesidad y posibilidad de beneficio según contexto.

CLAVE DE EXAMEN **Los primeros auxilios psicológicos ofrecen seguridad y apoyo práctico; no son debriefing obligatorio.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

Primeros auxilios psicológicos: mirar, escuchar y conectar

Los PAP ofrecen apoyo humano y práctico después de una crisis. No son un interrogatorio ni una sesión obligatoria de relato traumático.

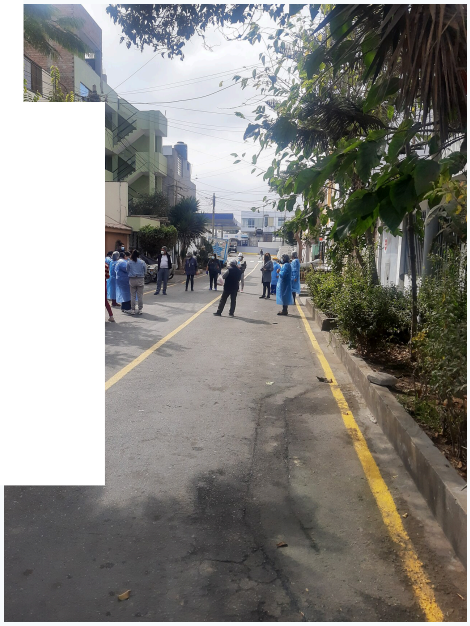
Principio	Acción	Evitar
Mirar	Comprobar seguridad, necesidades urgentes y personas que requieren asistencia especializada.	Entrar en un lugar inseguro o pasar por alto lesiones.
Escuchar	Presentarse, pedir permiso, atender necesidades y escuchar sin presionar.	Forzar detalles, juzgar o prometer resultados.
Conectar	Facilitar información comprensible, necesidades básicas, apoyos elegidos y servicios.	Separar innecesariamente de apoyos o compartir relatos sin fundamento.

Primero se atienden peligros y n
aguda, lesión importante, incapa
inmediato de daño, activar evalu
apoyo a edad, cultura, comunica

DIFERENCIA QUE IMPORTA

PAP: apoyo inicial flexible. Psic
evaluación y objetivos. Debrief
con PAP; no se exige revivir el

La mayoría de reacciones inmediat
diagnóstico. Registrar necesidades
automáticamente TEPT a toda persona expuesta. Preparar una ruta de seguimiento para quien continúe con deterioro o solicite ayuda.



Personal de salud en el simulacro de San Miguel, Lima (31 de mayo de 2022).

Henrry Labra Yabar · CC BY-SA 4.0. Sin recorte; escala proporcional.

Fuente

Fuentes: [N08].

conservan sus licencias

EJE 01 · CIERRE DE REPASO

Lo que debes poder explicar

Si una idea todavía no sale con tus propias palabras, vuelve al tema antes de practicar.

01 **Incidencia cuenta casos nuevos; prevalencia reúne casos existentes.**

02 **En causalidad, la temporalidad es indispensable: la exposición debe preceder al desenlace.**

03 **Prevención primaria evita aparición; secundaria detecta temprano; terciaria limita secuelas; cuaternaria evita sobreuso.**

04 **Vigilancia pasiva recibe reportes, activa sale a buscar y centinela observa con unidades seleccionadas.**

05 **Caso sospechoso inicia la p ple el criterio definitivo aplicable.**

NO LOS CONFUNDAS

Sensibilidad / especificidad	
VPP / VPN	
Brote / epidemia / endemia	Agrupación localizada / exceso esperado / presencia habitual

RECUERDA SIN MIRAR

1. **¿Qué dato diferencia incidencia de prevalencia en un caso?**
2. **¿Qué modalidad de vigilancia busca deliberadamente casos?**
3. **¿Por qué asociación no equivale automáticamente a causalidad?**

conservan sus licencias

Practica y comprueba

Casos originales . Responde antes de leer la explicación. La mención de una clave histórica se identifica expresamente.

CASO 01 · ORIGINAL

Una campaña reporta 24 positivos entre 120 personas tamizadas. ¿Qué puede afirmarse?

Respuesta razonada. La positividad es 20%. Es un indicador del grupo tamizado; no prueba prevalencia comunitaria ni confirma 24 diagnósticos.

CASO 02 · ORIGINAL

Una sustancia ajena al organismo aparece en una exposición. ¿Es necesariamente un veneno?

Respuesta razonada. No. Xenobiótico describe su carácter ajeno; la toxicidad depende de propiedades y condiciones de exposición.

CASO 03 · ORIGINA

¿Qué debes marcar al revisar

Respuesta razonada. B: notific práctica de examen no sustituye un protocolo de resp

conservan sus licencias

Fuentes de referencia

[T] MINSA · Temario de Psicología SERUMS 2026-II

Contenidos temáticos por carrera; publicación del 22/07/2026.

[E] MINSA · Cuadernillo oficial Psicología 2026-II

Preguntas 1, 4, 14, 21, 26, 28, 40, 46, 50, 52, 76 y 87. Claves históricas conservadas.

[X] IUPAC · Xenobiotic

Gold Book, entrada XT06755: definición química.

[L] MINSA · Plan estratégico multisectorial al 2030

Apartado sobre el plan local de salud y la autoridad local de salud.

Documentos consultados

[R017] MINSA. NTS 138-MINSA/2017/DGIESP. RM 574-2017/MINSA, 20-07-2017

§6.1.1.a, PDF p. 9: funciones del CSMC.

[R018] MIMP. Lineamientos de coordinación CEM-UPE-DEMUNA. RM 237-2024-MIMP, 13-07-2024

Anexo §§7.1.3-7.2.4, PDF pp. 14-16: comp

[R019] Ley 29973, Ley Genera da 24-12-2012

Arts. 70-73: OMAPED, coordinación y rect

[R020] INABIF. Asistencia eco cial actualizada en 2026; Ley 31405

Beneficiarios, asistencia económica y aco

[R050] OMS, Essential medici

Definición, criterios de selección y requisit nceptual, no sustituye el petitorio peruano.

[R051] RM N.□ 633-2023/MINS ME

Resolución completa leída. Artículo 4 deroga stas complementarias. No se revisaron todas las fichas del anexo ni se reproduce una lista de medicamentos.

[R052] OMS, ficha Resistencia a los antimicrobianos, versión disponible al corte

Verificada la relación entre uso indebido/excesivo y resistencia de los microorganismos.

[R053] DIGEMID, información institucional vigente al corte; ROF MINSA DS008-2017-SA y modificatorias

Funciones de autoridad nacional farmacéutica leídas; la página estaba actualizada el 07/10/2026.

[R054] CENARES, información institucional oficial, consulta 19/10/2026 UTC

Mandato de abastecimiento de recursos estratégicos para el sistema público leído.

[R055] DIGESA, información institucional oficial, consulta 19/10/2026 UTC

Ámbito de salud ambiental e inocuidad alimentaria verificado.

[R060] OMS. Cinco momentos para la higiene de manos

[R061] OMS. Preguntas frecuentes, Día Mundial de la Higiene de Manos 2025

Apartado sobre guantes e higiene de manos

[R062] CDC. Infection Prevention and Control Strategies for Seasonal Influenza in Healthcare Settings

conservan sus licencias

Droplet precautions; aerosol-generating procedures

[R063] CDC/NIOSH. Bloodborne Infectious Disease Risk Factors

Treatment; reporting

[R064] CDC. Management of Potentially Infectious Exposures and Illnesses

Background: vías percutánea, mucosas y piel no íntegra

[R066] CDC. Principles of Epidemiology in Public Health Practice, 3rd edition

Lección 1: causalidad e historia natural; lección 2: medidas estadísticas

[R067] OPS. Glosario sobre brotes y epidemias: un recurso para periodistas y comunicadores

Página impresa 2/PDF4, entrada Agente: presencia, presencia excesiva o ausencia relativa; copia en BVS de OPS

[R068] Guzzetta y colaboradores. Impact of a Nationwide Lockdown on SARS-CoV-2 Transmissibility, Italy

Definiciones y distinción de R0 y Rt

[R069] MINSA. Notificación de enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiológica

Definiciones operativas: personal responsable de vigilancia o delegado de la unidad notificante

[R070] CDC Perú. Vigilancia d

Sarampión-rubéola: definiciones de caso; l

[R071] MINSA. Prevención, di erú

5.1, página impresa 3 (PDF 5): caso sospec

[R072] MINSA. Atención inte

5.2, páginas impresas 8-9: definiciones y cl
https://www.gob.pe/institucion/minsa/nor

[R073] MINSA. Vigilancia epi gue, chikungunya, zika, Oropouche, Mayaro y otras a

5.1.52.1-5.1.52.3; páginas impresas 9-10. D
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/N

[R074] MINSA. Metodología par

Documento técnico de ASIS local; participación de actores y priorización

[R077] OMS/EMRO. Noncommunicable diseases: a major challenge to public health in the Region

Distinción entre prevención primordial y primaria

[R078] OMS. Primary health care

Servicios integrados, acción multisectorial y participación

[R083] MINSA. Modelo de abordaje de promoción de la salud en el Perú

Ejes temáticos, escenarios y enfoques transversales; documento https://bvs.minsa.gob.pe/local/promocion/203_prom30.pdf

[R084] Congreso de la República. Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud

Artículo 3

[R085] Congreso de la República. Incorporación al SIS de peruanos residentes en el exterior

Artículo único: modifica art. 3 de Ley 29344. Texto completo de El Peruano consultado; fecha corroborada en Boletín del Congreso, mayo 2024: https://www.congreso.gob.pe/Docs/Otamdegrl/files/boletin_mayo_2024_compressed.pdf

[R086] OMS. Universal health coverage: questions and answers

Servicios necesarios sin dificultades financieras

conservan sus licencias

[R087] OMS. A conceptual framework for action on the social determinants of health

Secciones 5.5-5.6; educación, ocupación e ingreso en posición socioeconómica; determinantes intermedios

[R088] OMS Europa. Public health advice on dengue fever

Aedes: actividad diurna, especialmente al amanecer y al final de la tarde

[R092] CENEPRED. Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, 2.ª versión

Clasificación de peligros de origen natural

[R093] CENEPRED. Manual para la elaboración de riesgos inducidos por la acción humana

Riesgos inducidos por acción humana

conservan sus licencias

Índice de temas

Tema	Página
01 Salud Pública y Funciones Esenciales	4
02 Mediciones epidemiológicas e indicadores	6
03 Causalidad, riesgo y criterios de Hill	10
04 Demografía y transición poblacional	18
05 Historia natural y niveles de prevención	21
06 Pruebas diagnósticas y tamizaje	23
07 Brote, epidemia, endemia, epizootia y pandemia	27
08 Vigilancia en Salud Pública	30
09 Prevención y control de infecciones	34
10 Uso racional de medicamentos	36
11 ASIS y sala situacional	38
12 Sistema Nacional de Vigilancia	40
13 Determinantes sociales de la sa	43
14 Determinantes ambientales	45
15 Participación comunitaria	47
16 Sectorización y ficha familiar	48
17 Intervenciones comunitarias	49
18 Trabajo intersectorial	50
19 Plan local de salud	51
20 Información sanitaria y TIC	54
21 Alimentación, nutrición e inocuida	55
22 Residuos sólidos en servicios de salud	56
23 Salud ocupacional y riesgos psicosociales	57
24 Modelo comunitario de salud mental	59
25 Barreras de acceso	61
26 Promoción de la salud	63
27 Información, educación y comunicación	64
28 Bioseguridad	65
29 Emergencias y desastres	66

conservan sus licencias

Referencias

[N05] CDC. Field Epidemiology Manual. Analyzing and Interpreting Data, capítulo 8

Documento de referencia

[N06] CDC. Field Epidemiology Manual. Designing and Conducting Analytic Studies in the Field, capítulo 7

Documento de referencia

[N07] CDC. Principles of Epidemiology, lección 3: medidas de riesgo

Documento de referencia

[N08] OMS. Psychological first aid: Guide for field workers, 2011

Documento de referencia

[N09] CDC/NIOSH. Hierarchy of Controls

Documento de referencia

[N10] OMS. mhGAP guideline, tercera edición, 2023

Documento de referencia

[N18] CEPLAN. Guía para la elab

Documento de referencia

[N21] MINSA. Contenidos temáti

Documento de referencia

conservan sus licencias

Créditos de imágenes

Snow-cholera-map.jpg

after John Snow. Public domain. Sin modificaciones; escalado proporcional en la composición.

Fuente

Licencia y condiciones

NIOSH Hierarchy of Controls.png

NIOSH. Public domain. Sin modificaciones; escalado proporcional en la composición.

Fuente

Licencia y condiciones

MINISTRA DE DEFENSA NURIA ESPARCH SUPERVISÓ JORNADA DE VACUNACIÓN AL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS - 50932346623.jpg

Galería de fotografías del Ministerio de Defensa. CC BY 2.0. Vista previa de Wikimedia, sin recorte ni retoque; escalado proporcional en la composición.

Fuente

Licencia y condiciones

Personal de salud.jpg

Henrry Labra Yabar. CC BY-SA 4.0. Vista p l en la composición.

Fuente

Licencia y condiciones

. . Las imág ón no implica aval de sus autores.

· · conservan sus licencias